

Chapitre 11 : Pathologies des troncs viscéraux

11.1. Introduction

- La vascularisation de l'intestin grêle et du côlon est assurée par : le tronc coeliaque (TC), l'artère mésentérique supérieure (AMS) et l'artère mésentérique inférieure (AMI).
- Il existe de nombreuses anastomoses entre ces 3 vaisseaux : entre le TC et l'AMS, entre l'AMS et l'AMI (arcade de Riolan), ainsi qu'entre l'AMI et les artères hypogastriques
- Les variations anatomiques sont fréquentes
- **Les pathologies décrites dans ce chapitre incluent :**
 - Les lésions sténosantes des troncs viscéraux qui peuvent être la cause d'un syndrome d'ischémie mésentérique chronique
 - L'occlusion aiguë d'un tronc qui peut être la cause d'un syndrome d'ischémie mésentérique aiguë
 - La colite ischémique

11.2. Lésions sténosantes des troncs viscéraux

a) Introduction :

Les lésions sténosantes des troncs viscéraux sont le plus souvent d'origine athéroscléreuse (> 95% des cas) et siègent le plus souvent à l'ostium ou sur les premiers centimètres du vaisseau.

- D'autres étiologies beaucoup plus rares sont : la dysplasie fibromusculaire, la maladie de Takayasu
-

b) Physiopathologie :

- La plupart des sténoses sont asymptomatiques en raison des nombreuses voies anastomotiques de suppléance
- Des manifestations cliniques d'ischémie mésentérique chronique peuvent s'observer lorsqu'il existe des lésions serrées ou des occlusions sur au moins 2 des 3 troncs

c) Présentation clinique :

- Patients le plus souvent > 50 ans et association avec d'autres atteintes athéroscléreuses (p.ex. AOMI)
- Symptômes et signes :
 - Douleurs abdominales après le repas (survenant précocement dans les 15-30 minutes)
 - Craintes vis-à-vis de l'alimentation (sitophobie)
 - Amaigrissement
 - Souffle systolique épigastrique

d) Examens complémentaires :

Les examens complémentaires confirment le diagnostic et permettent de guider la stratégie thérapeutique.

- Exploration ultrasonore (échographie-Doppler) : examen de dépistage
 - Avantages :
 - Innocuité
 - Limites :
 - Analyse segmentaire
 - Sujet obèse
- Angio-scanner :
 - Avantages
 - Bonne résolution des images avec les appareils de nouvelles générations, permet d'éviter le cathétérisme nécessaire pour l'angiographie conventionnelle.
 - Limites : calcifications volumineuses
- Angiographie par résonance magnétique
 - Avantages :
 - Innocuité
 - Limites :
 - Résolution des images
 - Tendance à surestimer les sténoses serrées
 - Artéfacts de flux, de reconstruction
- Angiographie conventionnelle, face et profil : considérée comme l'examen de référence
 - Avantages :
 - Étude complète de la vascularisation
 - Résolution des images
 - Limites :
 - Injection de produit de contraste

e) Traitement

Objectifs : Prévenir la récurrence de symptômes et l'ischémie mésentérique

- Généralités

- Bilan et contrôle strict des facteurs de risque de la maladie athéroscléreuse (HTA, tabac, cholestérol, diabète)
- Prévention médicamenteuse des accidents cardiovasculaires : antiagrégants plaquettaires (Aspirine, Clopidogrel)
- Traitement de la sténose proprement dite
 - Les lésions symptomatiques **uniquement** doivent faire l'objet d'un traitement
- Choix du type de traitement : chirurgical versus endoluminal ?
 - Traitement chirurgical*
 - Avantages :
 - Technique de référence (pontage par greffe veineuse, réimplantation aortique)
 - Traitement endoluminal*
 - De plus en plus utilisé

11.3 L'ischémie mésentérique aiguë

a) Introduction :

Les causes d'ischémie mésentérique aiguë sont :

- L'occlusion artérielle aiguë (~ 50-70% des cas).
- L'ischémie non-occlusive (~ 20%)
- L'occlusion veineuse (~ 10%)
- Autres causes extravasculaires : volvulus, hernie étranglée (voir cours de chirurgie digestive)

b) Physiopathologie :

Lésions cellulaires irréversibles si ischémie totale pendant 4 h.

Lésions ischémiques de la muqueuse d'abord (nécrose de l'épithélium).

Extension à la sous-muqueuse avec œdème et hémorragie, puis atteinte de la musculature (infarctus transmural, perforation, péritonite).

c) L'occlusion artérielle aiguë

- Les étiologies de l'occlusion artérielle aiguë sont :
 - Les embolies dans l'AMS, d'origine cardiaque le plus souvent ou embolies de microcristaux de cholestérol.
 - La thrombose in situ sur sténose athéroscléreuse préexistante
 - Plus rares: dissection aortique, traumatisme direct, vasculites, dysplasie fibromusculaire, thrombocytose
- Présentations cliniques
 - Pathologie cardiaque sous-jacente fréquente (FA, valvulopathie, infarctus, ...)

- Douleurs abdominales violentes, d'abord crampoïdes puis continues, (parfois paucisymptomatique chez le patient âgé), péri-ombilicales avec irradiation dans la fosse iliaque droite
- Nausées, diarrhée, méléna
- Examen clinique : souvent pauvre au stade précoce (légère sensibilité, douleurs « disproportionnées »), hypotension, choc
- Examens complémentaires
 - Biologie : leucocytose précoce, plus tardivement acidose métabolique, élévation des LDH
 - Tomodensitométrie : distension des anses intestinales, épaississement de paroi
 - Angiographie : visualisation de l'embolie : aspect caractéristique en cupule concave
- Traitement : l'objectif est de restaurer la circulation mésentérique et lever l'ischémie intestinale.
 - Héparinothérapie dès que le diagnostic est évoqué
 - Traitement chirurgical : embolectomie ou revascularisation par greffe veineuse en cas de thrombose in situ sur sténose athéromateuse
 - Résection intestinale plus ou moins étendue en cas d'infarctus

d) L'ischémie non-occlusive

- Les facteurs prédisposants sont :
 - Hypotension, choc
 - Bas débit cardiaque
 - Administration de catécholamines
- Physiopathologie : vasoconstriction mésentérique disproportionnée
- Diagnostic : artériographie conventionnelle (image « d'arbre mort »)
- Traitement de la pathologie inductrice, vasodilatateurs via le cathéter d'artériographie, anticoagulation

e) Thrombose veineuse mésentérique

- Introduction : on distingue :
 - La thrombose primaire : contexte d'anomalie de l'hémostase
 - La thrombose secondaire : contexte de néoplasie, pancréatite, maladie inflammatoire intestinale, splénectomie, post-opératoire, cirrhose, hypertension portale, contraception orale
- Présentation clinique
 - Douleurs abdominales pouvant évoluer depuis quelques jours
 - Nausées, ballonnement abdominal
 - Examen clinique : souvent pauvre au stade précoce (légère sensibilité, douleurs « disproportionnées »)
- Examen complémentaire
 - Tomodensitométrie : thrombus dans la lumière veineuse, épaississement de paroi intestinale

- Traitement : anticoagulation

11.4. La colite ischémique

a) Introduction

- Épidémiologie

Atteinte vasculaire digestive la plus fréquente (50 à 60 % des ischémies digestives)

Deuxième cause d'hémorragie digestive basse

Étiologie souvent multifactorielle

Lien épidémiologique avec HTA, diabète, pathologies cardiovasculaires

Pathologie du sujet âgé

Incidence dans la population générale :

-très variable selon le groupe d'âge

-en augmentation

- Etiologies

Non occlusives :

- Choc hypovolémique, cardiogénique, septique, anaphylactique
- Insuffisance cardiaque, déshydratation
- Médicaments vasoconstricteurs
- Effort physique intense prolongé
- Cocaïne

Occlusives :

- Thromboses et embolies des artères mésentériques :
 - embolies artérielles, embolies de cholestérol, ligature de l'AMI, anévrisme et reconstruction aortique, aortographie, dissection aortique, thrombose veineuse mésentérique
 - cirrhose, pancréatite aiguë, sepsis intra-abdominal
- Obstruction

	colique	:
cancer,	volvulus,	sténose,
	fécalome,	invagination,
		...
- Maladies hématologiques :
 - drépanocytose, thrombophilies, syndromes myéloprolifératifs, mutation JAK 2,
 - coagulation intravasculaire disséminée, polyglobulies secondaires,
 - hémoglobininurie paroxystique nocturne
- Vasculites

b) Présentation clinique

- Présentation clinique variable :
 - Douleurs abdominales flanc et fosse iliaque gauche, modérées
 - Rectorragies, diarrhée sanglante
 - Péritonite
 -

c) Examens complémentaires

- Tomodensitométrie avec injection de produit de contraste
 - diagnostic différentiel
 - vaisseaux mésentériques
- Sigmoidoscopie SANS INSUFFLATION pour ne pas déchirer la séreuse (souffrance ischémique)

d) Traitement

- Traitement médical symptomatique
 - Antibiothérapie large spectre, sauf forme légère,
 - Anticoagulation : si pas d'évidence d'ulcère hémorragique, thrombose veineuse mésentérique, étiologie cardio-embolique
 - Antiplaquettaire (selon les affections concomitantes) :
cf. Artériopathie oblitérante, cardiopathie ischémique
- Traitement chirurgical si complication (péritonite, hémorragie massive, échec traitement médical, sténose secondaire symptomatique)
- Traitement endovasculaire (lésions des troncs mésentériques)